

공유 교육과정 개발 및 사업(K-MedU 공유대학)

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

콘텐츠 공동 개발에서 품질심사·학습플랫폼 운영·학점 인정까지 이어지는 의과대학 간 공유 교육체계를 구축했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

26개교 · 참여대학

22개교 · 학점교류 협약

143명 · 임상윤리 활용 학생

- K-MedU 학습플랫폼과 대학·중앙관리자 운영체계를 구축했습니다.
- 강의개발 프로토콜 일반·Plus, 개설신청서·계획서, 저작물 이용 안내·동의서 등 표준 문서 6종을 마련했습니다.
- 5개 평가영역과 3단계 심의에 기반한 콘텐츠 품질관리 체계를 정립했습니다.
- 임상윤리 과정을 2개교·143명 대상으로 시범운영했으며 설문 58명의 평가 평균은 문항별 4.59~4.76입니다.
- 동영상 625건은 참여대학 575차시와 KAMC 50시수를 합친 '예정' 수치입니다. 완료된 탑재·이수 실적과 분리해 해석해야 합니다.
- 회의·워크숍 57회, 논문 원고 1건(투고 예정)을 보고했으며 보고서는 2026년 9월 1일 정식 개방을 예정입니다.

주요 산출물

- K-MedU 학습플랫폼
- 강의개발 프로토콜 2종
- 개설·저작권 표준 문서

- 품질평가표·심의절차·운영 매뉴얼

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

2025년 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)가 17개 시·도 전역에서 시행되면서 2개 이상의 대학이 공동으로 교육과정을 운영하는 '공유대학'이 정부 재정지원사업의 명시적 사업유형으로 자리 잡았고, 고등교육법 제21조제1항 단서와 같은 법 시행령 제13조·제15조가 대학 간 공동 교육과정 운영과 학점교류의 법적 근거를 제공하고 있다. 그러나 의학 분야에는 이를 실행할 전국 단위의 공유 기반이 존재하지 않는다. 국가 온라인 공개강좌 플랫폼(K-MOOC)의 의약 분야 강좌는 일반 학습자를 대상으로 한 교양·보건 강좌가 중심이고, 거점국립대학 원격수업 학점교류(KNU10) 역시 2023학년도 이후 개설 과목이 교양·기초 강좌에 한정되어 의과대학 전공 교육과정은 개설된 바 없다. 한편 국내 의과대학은 코로나19를 거치며 온라인 교육 경험을 전국적으로 축적하였으나(Park 등, 2021; Si, 2022), 콘텐츠 개발에 필요한 교수 인력·제작 인프라·재원은 대학 간 격차가 커 개별 대학이 독자적으로 고품질 온라인 콘텐츠를 지속 개발하기는 어렵다. 본 과제는 이러한 격차를 전국 단위의 공동 개발·공동 활용 체계로 해소하기 위해 추진되었다.

2. 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
공유 교육과정(K-MedU 공유대학)	전국 의과대학이 공동으로 개발하여 공동으로 활용하고, 대학 간 협약과 각 대학의 학칙에 따라 학점으로 인정하는 온라인·블렌디드 교육과정. 개별 대학이 자체 개설한 강좌를 타 대학 학생이 수강하는 기존의 학점교류와 달리, 개발 단계부터 공동 활용을 전제로 설계된다는 점에서 구별된다.	고등교육법 시행령 제13조·제15조; K-MedU 동영상 강의 개발 프로토콜(2026)
강의·모듈·시수	강의(과목)는 플랫폼에 개설되는 운영의 기본 단위로 총 15시수(15주 기준 1학점)를 원칙으로 한다. 모듈은 내용적으로 완결된 학습 단위이며 개수와 시수는 고정하지 않는다. 시수(차시)는 강의를 구성하는 시간 단위로 1시수가 1차시에 해당하며, 1차시는 25분 이상 35분 미만으로 구성하고 1~3개의 수업성과를 다룬다.	K-MedU 동영상 강의 개발 프로토콜(2026); K-MedU 강의개발 워크숍(2026.1.15.)
블렌디드 러닝·플립러닝	온라인 사전학습과 오프라인 대면수업을 연계하여 운영하는 방식. 학습자는 온라인에서 개념과 이론을 학습하고 오프라인에서 사례토의·역할극 등 적용 활동을 수행한다. 본 과제의 시범운영(임상윤리 교과목)이 채택한 운영방식이다.	Hew & Lo(2018); Spaic 등(2025)
상호작용(interaction)	온라인 학습에서의 상호작용은 학습자-콘텐츠, 학습자-교수자, 학습자-학습자의 세 유형으로 구분된다. K-MedU 콘텐츠 품질기준은 이 가운데 학습자-교수자 상호작용과 학습자-학습자 상호작용을 각각 독립된 평가 항목으로 둔다.	Moore(1989); K-MedU 콘텐츠 품질관리 평가표(2026)
탐구공동체(Community of Inquiry)	온라인 학습경험은 사회적 실재감·인지적 실재감·교수 실재감의 세 요소가 균형 있게 형성될 때 깊이 있는 학습으로 이어진다는 이론틀. 본 과제의 비실시간 동영상 강의 상호작용 설계 지침의 이론적 근거로 활용되었다.	Garrison, Anderson, & Archer(2000)
콘텐츠 품질관리	공유 콘텐츠의 최소 품질을 보장하기 위한 심사 도구와 절차. 교수설계·상호작용·평가·동영상·학습자료의 5개 영역을 평가하며, 대학 자체 검수와 KAMC 품질심사의 2단계 환류 체계로 운영한다.	Quality Matters Higher Education Rubric(7th ed.); K-MedU 콘텐츠 품질관리 평가표(2026)

3. 선행연구 및 문헌 고찰

문헌 검토는 KCI·RISS(국내)와 PubMed·PMC·Google Scholar(국외)를 대상으로 '공유 교육과정', '학점교류', '온라인 의학교육', shared curriculum, flipped classroom 등을 조합해 검색하여 국내 7편·국외 20편·법령 및 정책자료 12건을 선별하였다. 콘텐츠 설계의 이론적 근거로는 세 가지를 채택하였다. 온라인 강의에서 확보해야 할 상호작용을 학습자-콘텐츠·학습자-교수자·학습자-학습자로 구분한 Moore(1989)의 상호작용 3유형은 품질관리 평가표의 상호작용 영역과 '차시 내 상호작용 요소 1개 이상' 필수 요건의 근거가 되었고, 사회적·인지적·교수 실재감의 균형을 제시한 Garrison, Anderson과 Archer(2000)의 탐구공동체 이론은 2026년 1월 15일 강의개발 워크숍의 상호작용 설계 세션에 반영되었으며, 임상역량 평가 위계를 제시한 Miller(1990)는 온라인 콘텐츠가 담당할 수 있는 평가 수준의 범위를 설정하는 기준이 되었다.

선행연구는 세 가지 한계를 남긴다. 첫째, 국내 의학교육의 온라인 교육 연구는 대부분 단일 기관 데이터에 기반하고 있어 여러 대학이 콘텐츠를 공동 개발·공동 활용할 때 발생하는 문제를 다루지 못한다. 둘째, 대학 간 공유와 학점교류를 다룬 국내 연구는 교양·기초 분야를 대상으로 하고 있어 의학교육의 통합성과 임상 맥락, 인정 가능한 학점의 제한이 반영되어 있지 않다. 셋째, 국가 온라인 공개강좌 연구가 지적인 학사 일정 불일치와 평가 공정성 문제는 학점 인정을 전제로 하는 공유 교육과정에서 반드시 해결되어야 하나 그 해법은 제시되어 있지 않다. 한편 국외에서는 사전 녹화영상을 활용한 플립러닝이 전통적 강의 대비 지식 성취와 학생 만족도 모두에서 우수하다는 메타분석 결과가 축적되어(Hew & Lo, 2018; Spaic 등, 2025) 본 과제의 온라인 사전학습-오프라인 연계 설계를 뒷받침한다.

4. 국내외 사례 분석

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국내	한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC) — 교육부·국가평생교육진흥원	2015년 개시, 2026.8. 기준 8,300개 강좌(의약 분야 530개) 운영. 「학점인정 등에 관한 법률」에 따른 학점은행제로 학점을 인정하며, 2023.12. 표준 강의계획서를 배포하여 2024년 신규 강좌부터 필수 적용.	표준 강의계획서 배포와 품질관리 기준 정비 경로는 본 과제와 동일하다. 다만 학점 인정이 학점은행제 경로로서 대학 정규 학위과정 밖에 있고, 의약 분야도 일반 학습자 대상 교양·보건 강좌 중심이어서 의과대학 전공 교육과정을 포괄하지 못한다.
국내	거점국립대학 원격수업 학점교류(KNU10) — 강원대·경북대·경상국립대·부산대·서울대·전남대·전북대·제주대·충남대·충북대	2018년 국립대학 육성사업으로 시작, 2022.9. 협약 체결. 전 과정 온라인 운영·온라인 시험 평가. 개설 규모는 2023-1학기 33개 강좌에서 2026-2학기 54개 강좌로 확대.	콘텐츠 공동 활용과 학점교류를 대학 협의체가 공동 운영한다는 점에서 구조가 가장 유사하다. 그러나 개설 과목이 교양·기초에 한정되어 의과대학 전공 교육과정은 없다 — 국립대 네트워크조차 의학 분야를 포괄하지 못한다는 사실이 본 과제의 필요성을 뒷받침한다.
국내	충청권 국립대학 공동 교육혁신센터 (CHEC) 학점교류 — 충남대·충북대·국립공주대·국립한밭대·한국교원대 등	충청권 국립대학의 오프라인 학점교류. 2020-1학기 ~2025 동계 계절학기 실적 1,213건을 분석한 연구가 발표되었다(박병도, 2026).	교과목을 공급하는 순공여 대학과 유출 중심의 순수혜 대학으로 역할이 나뉘는 구조적 편중이 관찰된다. 본 과제에서도 동일하게 나타날 수 있어 참여 대학의 개발 참여를 고르게 유도하는 유인 설계가 필요하다.
국내	부산·경남 5개 의과대학 협력체계 — 경상국립대·고신대·동아대·부산대·인제대	2025.11.28. 「부산·경남 지역의료인재 양성을 위한 협의체」 발족(18인). 5개 대학이 각 1개 교육과정을 개발해 온·오프라인 블렌디드로 상호 활용하고, 공공의료기관 임상실습도 공동 기획·운영.	권역 단위에서 의과대학이 교육과정을 공동 개발·활용하는 모델로 문제 인식이 본 과제와 동일하다. 다만 대상이 권역 5개 대학에 한정되고 오프라인 실습 자원 공유의 비중이 크다.
국외	미국의과대학협회(AAMC) MedEdPORTAL / iCollaborative (미국)	동료심사를 거친 교육자원을 학술 출판물 형태로 발행하는 MedEdPORTAL과, 심사 없이 혁신사례를 자유롭게 공유하는 iCollaborative의 이원 체계로 운영.	품질을 보증한 콘텐츠와 자율 공유 자료를 구분해 운영하는 이원 구조는, 본 과제가 품질심사 통과 콘텐츠와 대학 자율 활용 자료를 구분해 관리하는 설계의 국제적 선례가 된다.

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국외	유럽 처방교육 개방 플랫폼(EurOP2E) — 유럽 15개국	유럽 임상약리·치료학 교육의 질을 조화시키기 위한 문제 기반 온라인 공개교육자원 공동 개발 플랫폼. 15개국 20명의 교수자가 명목집단기법으로 우선 공유 교육자료 35종을 선정(Bakkum 등, 2022).	기관 간 교육내용의 표준화를 목적으로 콘텐츠를 공동 개발한다는 점에서 목적이 가장 유사하다. 무엇을 먼저 공유할지를 교수자 합의로 결정하는 방식은, 본 과제가 워크숍과 수요조사로 개발 대상을 정한 방식과 대응한다.

5. 시사점 및 과제 설계 방향

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
기존 국가 온라인 플랫폼(K-MOOC, KNU10) 어디에도 의과대학 전공 교육과정을 학점으로 인정하는 공유 체계가 존재하지 않는다.	전국 의과대학을 대상으로 하는 공유 교육과정 플랫폼(K-MedU)을 별도로 구축하고, 고등교육법 시행령 제13조·제15조에 근거한 대학 간 학점교류 업무협약과 참여대학의 학칙 정비를 병행하여 정규 학위과정 안에서 학점이 인정되도록 설계하였다.
온라인 공개강좌의 낮은 이수율은 학사 일정 불일치와 평가 공정성에 대한 불신에서 비롯되며, 정규 교과와 연동될 때 개선된다.	온라인 콘텐츠를 단독으로 제공하지 않고 각 대학이 자기 학사일정에 맞추어 오프라인 수업과 연계해 운영하는 블렌디드 구조를 채택하였다. 아울러 콘텐츠를 개발하는 담당교수와 각 대학에서 실제 운영·평가를 책임지는 책임교수를 분리하는 이원 구조를 두어, 성적 부여와 학점 인정 권한이 학생 소속 대학에 남도록 하였다.
대학 간 공유 컨소시엄에서는 소수 대학이 콘텐츠를 공급하고 다수 대학이 수혜만 하는 역할 편중이 구조적으로 발생한다.	참여 대학을 지속적으로 확대하고 대학별 콘텐츠 개발 현황을 상시 관리하는 체계를 두었다. 개발에 참여하는 대학에는 강의개발 워크숍과 제작 프로토콜·표준 양식을 제공하여 개발 진입 장벽을 낮추었다.
온라인 강의의 학습 성과와 만족도는 시스템·학습자·교수자·상호작용 품질에 의해 좌우되며, 그 가운데 상호작용 설계가 특히 중요하다.	콘텐츠 품질관리 평가표에 교수설계·상호작용·평가·동영상·학습자료의 5개 영역을 두고, 상호작용 영역에서는 학습자-교수자 상호작용과 학습자-학습자 상호작용을 각각 독립된 항목으로 평가하도록 하였다. 모든 콘텐츠에는 차시 내 상호작용 요소를 1개 이상 포함하도록 필수 요건화하였다.
무엇을 공유할 것인지는 하향식 지정보다 교수자 합의 절차를 통해 정하는 것이 효과적이다.	참여(예정) 대학 실무진을 대상으로 온라인 콘텐츠 활용 여건과 개발 가능 교과목 범주를 조사하고(2025년 8월), 두 차례의 강의개발 워크숍(2025.12.15., 2026.1.15.)을 통해 개발 기준과 우선 개발 영역을 참여 교원의 합의로 확정하였다.

02 과제 목표 및 성과지표

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

구 분	내 용
최종 목표 (사업 종료 시점)	전국 의과대학이 공동 활용 가능한 공유 교육과정 콘텐츠·평가체계와 이를 운영하는 학습플랫폼(K-MedU 공유대학)을 구축하여, 대학 간 교육 자원 격차를 해소하고 지속 가능한 콘텐츠 공유·확산 체계를 정착시킨다.
1차년도 목표	① 공유 교육과정 플랫폼(K-MedU) 구축 및 운영 개시② 기초·임상·인문사회 분야 강의 콘텐츠 50개 개발 및 플랫폼 탑재
과제 범위 (포함·제외)	콘텐츠 개발기준 및 품질관리 체계 수립, 학습플랫폼(LMS) 구축·운영, 참여대학 발굴 및 학점교류 협약, 시범운영을 통한 운영모델 검증

2. 성과지표 및 목표치

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
1	플랫폼 개발	정량(Y/N)	K-MedU 학습플랫폼 개발 완료 여부	Y (개발 완료)	달성 — 2026.4.30. 구축 완료, 2026.9.1. 정식 오픈	100%
2	공유 교육과정 개발 수	정량	플랫폼 탑재 강의(차시) 수	50개	625건 — 참여대학 575차시 + KAMC 자체 개발 50시수	1,250%
3	공유 교육과정 활용 학생 수	정량	공유 교육과정을 수강한 학생 수	200명	143명 — 부산대 62명, 고신대 81명(「임상윤리」 시범운영). 정규 학기는 2026.9.1. 개강 예정	71.5%
기타	참여대학 수 및 학점교류 업무협약 체결 대학 수	정량	참여 의과대학 수 / 학점교류 업무협약 체결 대학 수	(계획 미설정)	참여 26개교 / 협약 체결 22개교	—
※ 성과지표 2번(공유 교육과정 개발 수) 실적은 2026. 8. 7. 현재 집계된 수치로, 실적이 아직 취합되지 않은 대학의 개발분이 추가되면 변동될 수 있다.						

03 추진 체계 및 방법

1. 추진 체계 및 조직

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
운영위원회(의학교육혁신사업)	위원장 및 관련 세부과제 위원	콘텐츠 품질인증 심사·자문, 사업 전체 의사결정 / 필요 시 소집
품질관리위원회	위원장(운영위원장 겸직) 포함 7인 이내	콘텐츠 품질인증 심사 및 환류·자문 / 심사 신청 시 소집
연구팀 정기회의(2-2 공유교육과정)	팀장 임선주 외 위원 10명, 간사 2명	과제 추진현황 점검, 정책·콘텐츠 기준 논의 / 월 1~2회(2025.7~)
플랫폼구축 실무회의	KAMC 사무국 실무자, 유비온 개발팀	플랫폼 기능·일정 점검 / 격주~수시(2026.1~)

2. 참여 대학·기관 현황

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
2	경희대학교	자문	김경숙(교수)	-
3	단국대학교	콘텐츠 제공	김명주(교수)	-
4	대구가톨릭대학교	자문	이현수(조교수)	-
5	동아대학교	콘텐츠 제공	김세진(조교수)	-
6	부산대학교	공동개발	임선주(교수)	-
7	부산대학교	콘텐츠 제공	이진령(계약교수)	-
8	부산대학교	콘텐츠 제공	신성희(교무팀장)	-
9	부산대학교	콘텐츠 제공	김태연(전임연구원)	-
10	제주대학교	공동개발	홍현미(조교수)	-
11	제주대학교	콘텐츠 제공	정소영(연구원)	-
13	연세대학교	콘텐츠 제공	서경수(교육파트장)	-
14	연세대학교	콘텐츠 제공	김남훈(담당직원)	-
15	충북대학교	자문	신형석(조교수)	-
16	충북대학교	자문	신지수(조교)	-

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
17	가천대학교	콘텐츠 제공	박귀화(교수)	-
18	가천대학교	콘텐츠 제공	차봉은(교육팀계장)	-
19	차의과학대학교	콘텐츠 제공	나승주(조교수)	-
20	차의과학대학교	콘텐츠 제공	이선민(과장)	-
21	차의과학대학교	콘텐츠 제공	홍영선(주임)	-
22	아주대학교	콘텐츠 제공	이장훈(교수)	-
23	아주대학교	콘텐츠 제공	유지혜(조교수)	-
24	아주대학교	콘텐츠 제공	김해미(담당직원)	-
25	고신대학교	자문	김민정(교수)	-
26	고신대학교	자문	이해영(교수)	-
27	고신대학교	자문	강명빈(담당직원)	-
28	전남대학교	자문	조화진(교수)	-
29	전남대학교	자문	송민근(교수)	-
30	전남대학교	자문	서형우(담당직원)	-
31	성균관대학교	자문	지영아(교수)	-

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
32	영남대학교	콘텐츠 제공	도경오(교수)	-
33	영남대학교	콘텐츠 제공	한예진(조교수)	-
34	영남대학교	콘텐츠 제공	최진희(담당직원)	-
35	영남대학교	콘텐츠 제공	서유리(담당직원)	-
36	영남대학교	콘텐츠 제공	구유진(연구원)	-
37	영남대학교	콘텐츠 제공	최현윤(담당직원)	-
38	원광대학교	공동개발	원형선(교수)	-
40	경북대학교	공동개발	여상희(교수)	-
41	가톨릭대학교	자문	유동미(연구부교수)	-
42	한림대학교	자문	박용순(교육부학장)	-
43	한림대학교	자문	최용준(교무부학장)	-
44	건양대학교	공동개발	천경희(교수)	-
45	건양대학교	자문	박은희(전임연구원)	-
46	건양대학교	자문	정수진(연구원)	-
47	건국대학교	자문	최종한(조교수)	-

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
48	동아대학교	콘텐츠 제공	문수경(담당직원)	-
49	계명대학교	자문	김신(부교수)	-
50	계명대학교	자문	박재형(부교수)	-
51	인하대학교	자문	장은지(박사)	-
52	순천향대학교	자문	이단비(조교수)	-

3. 연구·개발 방법

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	국내외 학술문헌 및 정책·법령 자료(국내 7편, 국외 20편, 법령·정책·기관자료 12건)	2026.7.~2026.8.	II.3·II.4의 문헌 검토 결과를 강의 개발 규격·상호작용 설계·품질관리 기준 수립에 반영하였다. 검색 전략과 이론적 근거(Moore, 1989; Garrison 등, 2000; Miller, 1990), 국내외 사례 분석은 II장 참조.
설문조사	① 「임상윤리」 시범운영 수강생 143명(부산의대 62명·고신의대 81명, 등록 명단 기준) — 설문 응답 58명② 전국 40개 의과대학 중 24개 교 소속 보직자 40명	① 2026.4.27.~5.8.② 2026년	① 온라인 사전학습-오프라인 연계 수업의 학습효과 및 플랫폼 사용성을 사전·사후로 평가(12문항 5점 척도, 개인 식별정보 없이 익명 처리)② 설계원칙의 중요도(5점 척도)와 운영방식 선호를 조사. 재정·인력 지원의 지속(M=4.28), 학사 운영의 유연성(M=4.25), 체계적 질 보증(M=4.15), 공통 규정 정비(M=4.13), 대학 주도 학점 인정(M=4.10) 순으로 우선순위가 확인되었고, 비실시간 운영·수강대학 성적 부여 권한·표준 서식·KAMC 주도 질 보증 선호가 나타나 플랫폼 정책과 2차년도 계획에 반영
FGI·FGD	대학 간 공동교육·학점교류·온라인 콘텐츠 제작 등 유사 사업 경험이 있는 실무 전문가 8명(목적표집 및 눈덩이 표집)	2025년~2026년 (설계 단계)	반구조화 개별 면담 후 성찰적 주제분석(reflexive thematic analysis). 공유 교육과정이 해결해야 할 4개 구조적 긴장 — 자발적 협력의 취약성, 표준화되지 않은 행정체계, 인정받지 못하는 교수 실행 노동, 경합하는 정당성 주장 — 을 도출하여 설계원칙 수립의 기초 자료로 활용
델파이 조사	의학교육 전문가 7명	2026년 (2라운드)	2라운드 델파이. 각 설계원칙에 대해 타당도·실행가능성의 문항수준 내용타당도지수(I-CVI)를 산출하여 검토·수정하였고, 교육설계 / 거버넌스·운영 / 질 보증·지속가능성 3개 영역 15개 설계원칙으로 확정. 확정된 원칙은 플랫폼 운영정책·품질관리 기준·학점 인정 구조 설계에 반영
워크숍·합의회의	참여대학 위원 11~18명, 간사 2명, 대학별 실무위원 및 실무담당자	2025.7.~2026.8. (연구팀 정기회의 9회, 실무위원회 회의 4회, 강의개발 워크숍 2회)	콘텐츠 개발기준·품질관리기준·플랫폼 정책 수립에 반영
시범운영	「임상윤리」 교과목 2개교(설문조사 ①과 동일 대상)	2026.4.27.~5.8.	플랫폼 기능 개선 및 콘텐츠 품질관리 프로세스 보완에 반영

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
기타	해당없음	-	-

4. 연구윤리

구 분	내 용
IRB 심의 여부	■ 승인 □ 심의면제 □ 해당없음서울대학교 의과대학·서울대학교병원 의학연구윤리심의위원회 승인(IRB No. E-2212-032-1383). 전문가 면담 (FGI)·델파이 조사·기관 설문조사는 해당 승인 아래 수행하였으며, 모든 참여자로부터 사전 동의를 받고 헬싱키 선언을 준수하였다. 면담 자료는 참여자 동의 아래 녹음·전사한 뒤 익명화하였다.「임상윤리」 교과목 파일럿의 사전·사후 설문은 학습효과 및 플랫폼 사용성 평가를 목적으로 개 인 식별정보 없이 익명 처리하여 시행하였다.
개인정보 보호 조치	(1) 회원 개인정보: 「K-MedU의과대학공유대학 개인정보처리방침」에 따라 회원가입·서비스이용·학술연구 목적별로 수집 항목·보유기간을 구분 관리하며, 학술연구·통계 목적 처리 시 가명처리 원칙 적용(개인정보보호법 제28조의2). 학습효과 분석 기능은 현재 미개발 상태이며, 향후 도입 시 사전 고지 예정. (2) 강의 촬영 시: 「(양식)KAMC공유대학_VOD강의촬영_개인정보수집동의서」로 촬영 참여자 동의 수령. (3) 환자 임상자료: FAQ(Q25)에 따라 식별정보 완전 차폐·안면 블러링/크롭·메타데이터 삭제 등 비식별화를 원칙으로 하며, 비식별화가 불가능한 경우 별도 서면 동의 필요

5. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계	2025.7.~2025.8.	kick-off 미팅(7.26) 개최, 실무위원회(11개 위원대학) 구성, 연구 기대성과 및 기본방침 수립, 온라인 콘텐츠 활용범위(최대 25%) 등 초기 운영기준 논의	추진계획(안), 실무위원회 명단
2단계	2025.9.~2025.12.	온라인수업 질관리·학점인정 체계 논의, 저작권·윤리 가이드라인 방향 수립, 강의개발 계획서 마련 및 대학 실무진 협의, 참여대학 수요조사, 강의 개발 1차 워크숍 개최(2025.12.15. 부산의대)	강의개발 계획서 양식, 수요조사 결과
3단계	2026.1.~2026.2.	학습플랫폼 구축 착수(요구사항·운영 분석, 정보구조도·디자인시스템 설계), K-MedU 강의개발 2차 워크숍 개최(2026.1.15. 서울의대), 콘텐츠 촬영·편집 실무 착수, K-MedU 학점교류 업무협약(MOU) 추진, 콘텐츠 품질관리·저작권 정책 수립(2.28)	플랫폼 설계(안), K-MedU 업무협약서, 콘텐츠 품질관리 평가표
4단계	2026.3.~2026.5.	플랫폼 UI/UX 개선 및 접근권한 체계 정비, 참여대학별 교과목 개발현황 점검, 콘텐츠 질관리 프로세스 정비, 임상윤리 교과목 파일럿 준비·시행(부산대), 대학관리자 교육 준비	대학관리자·중앙관리자 운영 매뉴얼(초안), K-MedU 강의개발 FAQ v2
5단계	2026.6.~2026.8.	LMS 설명회 개최(6.9), 이용약관·개인정보처리방침 확정, 콘텐츠 품질관리 심사 프로세스 재정의 및 심사위원 풀 구성, 콘텐츠 업로드(~8.31) 및 1차년도 시범운영 개시	이용약관·개인정보처리방침(확정본), 대학관리자 매뉴얼(확정본), 시범운영 강좌 목록

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

2025.7.26. 킥오프 미팅에서 온라인 콘텐츠 활용 범위(최대 25%)와 제도 정비 우선순위를 논의하여, 2025년 말까지 가이드라인·내규 정비를 마치기로 합의하였다. 이어 2025년 7~11월 동안 연구팀 정기회의를 9회 개최하여 참여대학 요구조사 설계, 온라인 수업 질관리 방안(담당교수·책임교수 이원구조), 수업설계 가이드라인, 강의개발 계획서 초안을 순차적으로 논의하였으며, 계획서가 복잡하다는 현장 의견을 반영해 양식을 단순화하기로 결정하였다(2025.11.27.). 강의개발 워크숍은 2025.12.15. 부산대학교 의과대학(1차)과 2026.1.15. 서울대학교 의과대학(2차) 두 차례 개최하여 강의 개발 규격(1차시 25~35분, 15시수=1학점)과 표준 강의 계획서 양식을 확정하였다. 2026년 1월에는 학습플랫폼 구축에 착수하였고, 2월에는 KAMC 정기총회에서 플랫폼을 시연하는 한편 학점교류 업무협약(MOU) 추진과 콘텐츠 품질관리·저작권 정책을 수립하였다(2.28.). 3~5월에는 참여대학별 교과목 개발현황을 점검하며 플랫폼 UI/UX를 개선하고, 부산대학교·고신대학교를 대상으로 임상윤리 교과목 파일럿 운영을 개시하였다(4.2. 준비, 4.27.~ 운영). 6월에는 LMS 설명회(6.9.)를 개최하여 참여대학에 플랫폼 사용법을 안내하였고, 7월에는 온라인 설명회(7.14.)를 추가로 열어 강의 개설·콘텐츠 업로드 절차를 안내하는 한편, 콘텐츠 품질관리 심사 프로세스를 심사위원 개별평가+심사위원장 종합의견 방식으로 재정의하고 약 120명 규모의 심사위원 풀 구성 계획을 확정하여, 2026.8.31. 콘텐츠 업로드 마감 및 9월 시범학기 운영을 준비하는 단계로 1차년도를 마무리하였다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

연구회의(연구팀 정기회의)	9회	128명	사업 방향 설정, 정책·제도 정비, 콘텐츠 개발·질관리 기준 합의	팀장·위원·간사 참석. 2025.7.~11. 월 1~2회 개최(참석 10~18명)
실무위원회 회의	4회	69명	콘텐츠 품질관리 기준 확정, 대학별 개발현황 점검, 참여 확대 협의	위원 및 참여대학 실무위원 참석. 2026.4.21. 회의는 35명 규모
강의개발 워크숍	2회	60명 이상	K-MedU 강의개발 표준화 및 교수 역량 강화	1차 2025.12.15.(부산의대) / 2차 2026.1.15.(서울의대). 2차는 참가신청 44명·운영 및 발표진 16명. 1차는 참석자 명단 미보존
세미나·설명회	3회	40명 이상	대외 플랫폼 시연(KAMC 정기총회), LMS·시스템 사용법 안내	2026.7.14. 온라인 설명회 신청 약 30명. 총회 시연 참석자 명단 미보존
실무진 회의	39회	330명	플랫폼 개발, 콘텐츠 제작·촬영, 품질관리, 약관·정책 등 실무 조율	개발사(유비온·에듀콕) 합동회의 포함. 참석자 명단 미기재 6건은 연인원 집계에서 제외. 회차별 내역은 [부록 2] 참조
합 계	57회	627명 이상	-	회의록·자료 실물 기준 집계. 주요 회의 18건은 아래 「나. 회차별 세부 실적」에, 실무진 회의 39건은 [부록 2]에 수록

나. 회차별 세부 실적

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
1	연구회의	2025.7.26.	서울대 의과대학 융합관 GDR 1	kick-off 미팅 — 연구 기대성과 및 기본방침 안내	‘adapted expertise’ 역량 강조, 온라인 콘텐츠 활용 최대 25% 우선 적용, 2025.12.까지 제도·규정 정비 우선 추진, 8.6. 플랫폼 데모 심사 결정 (참석 13명)
2	연구회의	2025.7.30.	서울대 의과대학 융합관 GDR 1	정책·제도 정비 및 콘텐츠 구성·운영 기준	공유 교육과정 전용 규정 또는 예외조항 필요성 확인(대학별 blended 제한 등), 콘텐츠를 전체 코스·개별 모듈 등 다양한 형태로 구성 가능하도록 함 (17명)
3	연구회의	2025.8.11.	온라인(Zoom)	참여대학 요구조사 설문 일정 및 동영상 개발 지침	설문 일정 확정(~8.29. 분석), 공유대학 규정에 질관리 절차 포함, 동영상 개발 지침 초안(영상 길이·영상 후 퀴즈·파일 규격 명시) 방향 합의 (10명)
4	연구회의	2025.8.13.	온라인	요구조사 설문 문항 확정	설문 서문에 공유대학 필요성(교육자원 격차·신분야 대응·인프라 편차) 반영, 교과목 범주를 기초·임상·인문·사회·선택융합+기타로 확정, 과목명·시수 및 우선순위 3개 문항 추가 (15명)
5	연구회의	2025.8.30.	서울대 의과대학 융합관 GDR 3	제2차 회의 — 연구기간 변경 및 동영상 콘텐츠 제작기준	연구기간 2026.8.까지 연장 확인, 콘텐츠를 정규수업 전면 대체가 아닌 보충·재교육·elective 중심으로 활용하는 방향 정리 (13명)
6	연구회의	2025.9.3.	온라인	KAMC·대학 간 콘텐츠 개발 역할 분담	KAMC는 AI·HSS·시민교육 등 개별 대학 개발이 어려운 영역을, 각 대학은 기초·임상·의료인문학을 담당하도록 역할 구분. 전국 단위 공동 LMS 구축 및 대학 학사 시스템 연동을 핵심 과제로 확인 (14명)
7	연구회의	2025.9.27.	서울대 의과대학 융합관 522	제3차 회의 — 온라인 수업 질관리 및 학점인정 체계	담당교수(콘텐츠 개발)·책임교수(운영·관리) 이원구조 확립, 대학별 책임교수 지정, 온라인 콘텐츠와 오프라인 실습·토론 병행 원칙 확인 (13명)

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
8	연구회의	2025.10.25.	서울대 의과대학 GDR 2	제4차 회의 — 수업설계 가이드 라인·질관리·성과지표	수업설계 가이드라인 초안을 11.20. 대학 실무진 회의에서 공유하기로 결정, 콘텐츠 질관리 체계 수립 착수, 11월 성과지표 초안 도출 및 LMS 반영 추진 결정 (15명)
9	연구회의	2025.11.27.	온라인(Zoom)	제5차 회의 — 강의개발 계획서 검토 및 워크숍 준비	계획서 구조 단순화 및 개발자·운영자 역할 구분 명확화 추진 결정, 12.15.(부산)·1.15.(서울) 강의개발 워크숍 2회 개최 준비 확정 (18명)
10	강의개발 워크숍	2025.12.15.	부산대학교 의과대학	K-MedU 강의개발 1차 워크숍	공유대학 안내(임선주), 온라인 동영상 강의 개발(개발업체), 상호작용 설계(홍현미), 온·오프라인 연계 액티브러닝 설계(천경희) 등 세션 운영. 강의별 녹화본 및 부산대 샘플영상 보존
11	강의개발 워크숍	2026.1.15.	서울대 의과대학 융합관 박희택홀	K-MedU 강의개발 2차 워크숍 — 온·오프라인 연계 액티브 러닝 설계	강의 개발 규격(1차시 25~35분, 15시수=1학점, 주제 단위 모듈 구성), 표준 강의계획서 양식, 대학 자체 검수→KAMC 품질심의 2단계 환류 체계 확정. FAQ 세션 병행. 참가신청 44명(운영·발표진 16명 별도)
12	세미나·설명회	2026.2.26.	프레이저플레이스 센트럴서울	KAMC 정기총회 — 공유대학 플랫폼 시연	학사일정·원격교육 규정 상이에 따른 운영상 쟁점 확인, 성적부여·학점인정 권한은 학생 소속대학이 보유하는 유연한 구조로 운영 방향 확정
13	실무위원회	2026.2.28.	서울의대 융합관 522호	콘텐츠 품질관리 및 플랫폼·저작권 정책	업로드→검수→오픈(학점인정) 절차, 일반/코어플러스 콘텐츠 이원 심의, 저작권·초상권·윤리 리스크 체크리스트, 콘텐츠 사용기간(기본 3년) 등 품질관리 체계 확정 (13명)
14	실무위원회	2026.3.27.	온라인(Zoom)	플랫폼 개발 현황 점검 및 심사 절차 정정	대학 자체개발 일반 콘텐츠는 예비심사를 생략하고 본 심사를 진행하도록 정정, 환자·의료진 인터뷰는 '사용 금지'에서 '비식별 또는 동의 후 사용 가능'으로 수정 (11명)

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
15	실무위원회	2026.4.21.	서울의대 교육관 105호	콘텐츠 질관리 프로세스 및 참여 대학별 교과목 개발현황 점검	심사절차 정정사항 공유, 플랫폼 기능 시연, 참여대학별 교과목 개발현황 일괄 점검 (35명 — 1차년도 최대 규모 회의)
16	실무위원회	2026.4.29.	온라인(Zoom)	플랫폼 개발 현황 및 참여 확대 전략	임상윤리 파일럿 결과 공유(콘텐츠 품질 플립러닝에 대한 긍정적 반응), 단국대·충남대·충북대·순천향대의 MOU 등 참여 절차 신속 진행 합의, 교육부에 5년간 운영비 지원 요청 (10명)
17	세미나·설명회	2026.6.9.	서울의대 교육관 309호	공유대학 LMS 설명회	LMS 주요 기능·운영 구조 안내 및 시연(강의 개설, 콘텐츠·수강생·학습이력 관리), 참석자 질의응답 및 의견 수렴
18	세미나·설명회	2026.7.14.	Zoom 온라인	K-MedU LMS 강의 개설 및 콘텐츠 업로드 온라인 설명회	신청→심사→개설에 이르는 전체 프로세스 시연, 중앙관리자-대학관리자-대학운영자 3단계 역할 체계 안내. 20개 미만 대학 약 30명 신청

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모(N)	실시 결과 요약
임상윤리 교과목 시범운영	부산의대·고신의대 학부생 및 교수·조교	부산대 학생 62명·교수/조교 약 7명, 고신대 학생 81명 — 등록 명단 기준 학생 합계 143명 (2026.4.2. 준비, 4.27.~4.30. 4일간 운영)	온라인 사전학습(월~화) 후 오프라인 토론(화~목)의 플립러닝 방식으로 운영. 사전·사후 비교를 통한 학습효과·플랫폼 사용성 평가 병행(개인 식별정보 없이 익명 처리)
플랫폼 베타테스트	콘텐츠 개발 참여 교수	교과목 개발 교수 대상	임시 계정으로 강의계획서·콘텐츠 직접 업로드 체험, 플랫폼 안정성·사용성 피드백 수렴(2026.4.21. 회의)
참여대학 수요조사	참여(예정) 의과대학 실무진	2025.8.~8.29. 설문 회신	온라인 콘텐츠 활용 여건, 개발 가능 교과목 범주(기초·임상·인문사회·융합) 등을 조사하여 공유대학 설계·정책 수립 기초 자료로 활용

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

변경 항목	당초 계획	변경 내용	변경 사유
사업(연구) 기간	2025.6.~2026.5. 종료 예정	2026.8.31.까지 연장	교육부 사업 일정 조정에 따른 연구기간 연장(2025.8.30. 제2차 연구회의에서 확인)
콘텐츠 품질관리 심사 방식	심사위원장이 심사위원 의견을 취합해 직접 품질평가표와 최종결과를 작성하는 구조로 시스템 구현	심사위원별 개별 품질평가표 작성 + 심사위원장은 종합평가·종합의견만 작성하는 방식으로 재정의	학술논문 심사(리뷰어+편집위원장) 방식과의 정합성 확보 및 평가 책임 소재 명확화(2026.7.21.·7.27. 회의)
1차년도(시범학기) 수강신청 방식	일반 학기와 동일하게 학생 사전 수강신청 절차 운영 예정	대학 담당자가 수강대상 학생을 분반에 수동 등록하는 방식으로 전환, 자율 유입 희망자는 청강으로 구분	시스템·콘텐츠 안정화 및 40개 의과대학의 상이한 학사일정을 고려한 조치(2026.7.21. 회의)
2차년도 성과지표 목표치	공유과정 개발 수 55개 / 공유과정 활용 학생 수 400명 (KAMC 핵심성과지표 Y2)	신규 공유 교육과정 강의 개발 20건 / 공유 교육과정 강의 품질 심사 500개 강의 / 활용 워크숍 1회 / 공유 교육과정 활용 학생 수 200명	1차년도에 참여대학 개발분을 포함한 콘텐츠가 625건에 이르러 개발 수의 추가 확대보다 이미 개발된 콘텐츠의 품질 심사와 실제 활용이 2차년도의 실질 과제가 되었기 때문이다. 활용 학생 수는 정규 학기 운영 첫 해임을 고려하여 1차년도 목표치(200명)를 이월·재설정하였다.

05 주요 결과 및 성과물

1. 핵심 결과 요약

첫째(성과지표 ① 플랫폼 개발, 달성률 100%). 전국 의과대학이 공동으로 활용하는 공유 교육과정 학습플랫폼 K-MedU를 2026년 4월 30일 구축 완료하고, 테스트 기간(2026년 5~8월)을 거쳐 2026년 9월 1일 정식 오픈한다.

둘째(성과지표 ② 공유 교육과정 개발 수, 달성률 1,250%). 목표 50개 대비 625건의 온라인 강의 콘텐츠를 개발하였다 — 참여대학이 개발한 575차시(22개교·73개 모듈, 2026년 8월 4일 기준)와 KAMC가 자체 개발하여 납품받은 50시수(2026년 7월 31일)의 합계이며, 아직 실적이 취합되지 않은 대학의 개발분이 반영되면 실적은 더 늘어난다.

셋째(성과지표 ③ 공유 교육과정 활용 학생 수, 달성률 71.5%). 목표 200명 대비 143명이 「임상윤리」 공동 교육과정 시범운영에 참여하였다(부산대학교 62명·고신대학교 81명, 설문 응답 58명·12문항 5점 척도 평균 4.59~4.76). 정규 학기 운영이 2026년 9월 1일 개시되므로 잔여분은 2차년도 초에 충족될 전망이다.

넷째(추가 달성 지표 — 참여대학 수 및 협약 체결 수). 전국 40개 의과대학 가운데 26개교가 K-MedU에 참여하고 있으며, 이 가운데 22개교와 학점교류 업무협약을 체결하여 공유 교육과정 이수 결과가 정규 학점으로 인정될 수 있는 제도적 근거를 확보하였다.

다섯째, 콘텐츠 개발부터 심사·운영에 이르는 표준 문서 6종을 확정하여 2차년도 정규 운영의 기준 문서로 승계한다 — 강의개발 프로토콜 2종(일반·K-MedU Plus), (통합)강의·모듈 개설신청서+계획서 양식, 저작물 이용 안내 및 활용 동의서, 콘텐츠 품질관리 평가표 및 심사 프로세스(교수설계·상호작용·평가·동영상·학습자료 5개 평가영역, 접수-예비심사-본심사-개설심의 3단계 심의), 대학관리자·중앙관리자 운영 매뉴얼.

2. 산출물 총괄표

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	K-MedU 의과대학 공유대학 학습플랫폼 [성과지표 ①]	플랫폼·시스템 (LMS)	코스웨어·회원관리·콘텐츠 업로드·품질심사 기능 포함	2026.4.30.(구축 완료) / 2026.9.1.(정식 오픈)	완료	[부록 1] 파일 1
2	공유 교육과정 동영상 콘텐츠 625건 [성과지표 ②]	강의콘텐츠(동영상)	참여대학 개발 575차시(22개교·73개 모듈) + KAMC 자체 개발 50시수(교안 50개·국영문 자막 각 50개 포함)	2026.7.31.(KAMC분) / 2026.8.4. 기준(참여대학분)	완료 — 일부 대학 실적 취합 중	플랫폼 탑재분 — 파일 첨부 대상 아님(근거: [부록 4] 에듀콧 제작 완료보고서, 「대학관리자 관리문서_20260804.xlsx」)
3	학점교류 업무협약서 22건 [추가 달성 지표]	협약 문서	참여 26개교 중 22개교와 체결	2026.8. 현재	완료(계속 확대)	[부록 4] K-MedU 업무협약서[원본]
4	「임상윤리」 공유 교육과정 시범운영 결과 [성과지표 ③]	조사보고서	2개교 143명 운영, 설문 응답 58명·12문항 5점 척도	2026.5.8.	완료	본문 VI.4 시범운영 결과
5	K-MedU 강의개발 프로토콜 (일반/KMedU Plus)	제작기준·매뉴얼	동영상 강의·수업보조자료 제작 기준 문서 2종	2026.3.	완료	[부록 1] 파일 2-1~2-3
6	(통합)강의·모듈 개설신청서 + 계획서 양식	표준 양식	강의개발 신청 및 강의계획 통합 양식	2026.3.19.	완료	[부록 1] 파일 3-1-3-2
7	K-MedU 저작물 이용 안내 및 활용 동의서	가이드라인	저작권법·개인정보보호법 기반 이용기준 및 동의서	2026.3.11.(최종본)	완료	[부록 1] 파일 4
8	K-MedU 콘텐츠 품질관리 평가표·심사 프로세스	평가도구·프로세스 문서	예비심사~본심사~개설심의 체크리스트	2026.7.	완료	[부록 1] 파일 5-1~5-3

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
9	대학관리자·중앙관리자 운영 매뉴얼	운영 매뉴얼(PPT)	대학관리자용·중앙관리자용 2종	2026.7.27.(최신본)	완료	[부록 1] 파일 6-1~6-3

3. 산출물별 상세 내용

항 목	내 용
산출물명	K-MedU 의과대학 공유대학 학습플랫폼
개발 절차	요구사항·운영·환경 분석(2026.1) → 정보구조도·디자인시스템·화면설계(2026.1) → 서버구축·시스템개발(2026.1~2) → 단위·통합·인수 테스트 및 매뉴얼·교육(2026.2~) → 콘텐츠 업로드 및 시범운영(~2026.8)
주요 구성·목차	코스웨어(강의 개설·수강), 회원관리(대학관리자·중앙관리자 권한 관리), 콘텐츠 품질심사(예비·본심사), 통계 관리, Mobile 연동
타당화·검증 근거	개발사(유비온) WBS 기반 단계별 진척관리, 콘텐츠 품질관리 심사프로세스(심사위원 2~3인 개별평가+심사위원장 종합판정) 도입, 부산대학교 임상윤리 교과목 파일럿을 통한 실사용 검증
활용 방법 및 배포 계획	참여대학 교원 계정 발급 후 강의 개설·콘텐츠 업로드. 2026.9월 학기부터 시범운영 학기 개시(대학 담당자의 수강대상 학생 수 동 등록 방식). 정식 수강신청 방식으로의 전환은 차기 학기에 논의·확정 예정
한계 및 보완 필요사항	대학별 학사일정·원격교육 이수 규정 상이에 따른 운영 조정 필요, 지속가능한 비용분담 모델 미정(Ⅷ.4 참고), 인터랙티브 퀴즈 등 일부 고급 기능은 추가비용 문제로 개발 보류

항 목	내 용
산출물명	K-MedU 강의개발 프로토콜(일반 / K-MedU Plus)
개발 목적·활용 대상	참여대학 교원과 콘텐츠 제작 기관이 동영상 강의와 수업보조자료를 일관된 기준으로 개발·제출하도록 안내하는 운영 기준. 각 의과대학 공유대학 사업 담당자(일반 버전)와 K-MedU 코어플러스 콘텐츠 개발 기관(대학·학회) 담당자(Plus 버전)가 활용 대상
개발 절차	2026.1.15. K-MedU 강의개발 워크숍에서 개발 기준 논의·확정 → 초안 작성 → 개발 주체와 품질관리 방식에 따라 일반 버전과 K-MedU Plus 버전 2종으로 분화 → 2026.3. 안내용 패키지로 배포
주요 구성·목차	① 목적과 사용법 ② 용어 정의(강의·과목/모듈/시수·차시/학습성과 연계) ③ 전체 단계 요약 ④ 단계별 상세 프로토콜(일반 3-1~3-12단계, Plus P-1~P-15단계) ⑤ 문의 및 지원. 핵심 규격: 1개 강의 = 15시수(15주 기준 1학점), 1차시 25분 이상 35분 미만, 모듈은 내용적으로 완결된 학습 단위(개수·시수 고정 없음)
타당화·검증 근거	강의개발 워크숍 참여 교원 의견 수렴, 실제 콘텐츠 개발 대학(단국대·인하대 등)의 적용 경험 환류, 「K-MedU_강의개발_FAQ_v2」(1차 배포 후 실제 제기된 질문 20문항 반영)를 통한 보완
활용 방법 및 배포 계획	강의 개발 신청 대학·기관에 안내용 패키지 형태로 배포하며, 콘텐츠 품질관리 심사 기준과 연동하여 적용. 대학별 상황에 따라 KAMC 사무국과 협의하여 절차 조정 가능
한계 및 보완 필요사항	대학별 제작 여건·원격교육 규정 차이로 일부 단계의 적용 편차 발생. 개정 주기와 개정 절차는 아직 확정되지 않음

항 목	내 용
산출물명	(통합)강의·모듈 개설신청서 + 강의·모듈 계획서 양식
개발 목적·활용 대상	강의 개발 신청과 강의계획 수립을 하나의 문서로 처리하기 위한 표준 양식. 콘텐츠를 개발·개설하려는 참여대학 교원이 작성
개발 절차	2025.11.27. 연구회의에서 "계획서 구조가 복잡하다"는 현장 의견 확인 → 구조 단순화 및 역할(개발자·운영자) 구분 명확화 → 2026.1.15. 워크숍에서 표준 양식 확정 → 2026.3.19. 통합 양식으로 최종 배포
주요 구성·목차	개설신청 정보(대학·책임교수·강의명·시수·학점), 교과목 개요 및 학습성과, 모듈·차시별 구성표, 주차별 학습성과 진술, 평가계획, 하이브리드(온·오프 연계) 수업 설계안
타당화·검증 근거	2026.1.15. 워크숍에서 경북의대 여상희 교수의 작성 가이드 세션을 통해 참여 교원 대상 시연·피드백 수렴. 학습성과-수업방법-평가방법의 일치(alignment) 원칙을 양식 구조에 반영
활용 방법 및 배포 계획	강의 개발 신청 시 필수 제출 서류로 활용하며, 플랫폼 강의 개설 및 품질심사 단계에서 심사자료로 사용. 작성 요령은 One-page Tips(「공유대학 강의계획서 작성 Tips」)로 함께 배포
한계 및 보완 필요사항	학습성과를 평가 가능한 행동동사로 진술하는 데 작성자 간 편차가 있어 추가 예시·컨설팅 필요

항 목	내 용
산출물명	K-MedU 저작물 이용 안내 및 활용 동의서
개발 목적·활용 대상	공유 콘텐츠의 저작권 귀속과 이용 범위를 명확히 하고, 개발 교원의 권리와 대학·KAMC의 활용 권한을 조정하기 위한 가이드라인 및 동의서. 콘텐츠를 개발·제공하는 교원과 소속 대학이 활용 대상
개발 절차	2025.7.26. 킥오프 미팅에서 "강의 저작권은 KAMC 소유 가능하나 제작자 권리 명시 필요"라는 원칙 확인 → 2026.2.3. 초안 → 법적 검토 → 2026.3.11.·3.12. 개정을 거쳐 최종본 확정
주요 구성·목차	저작권법·개인정보보호법에 근거한 이용 기준, 저작권 귀속 및 이용허락 범위, 이용 기간, 초상권·개인정보 처리 사항, 제3자 저작물 인용 시 출처 표시 의무, 활용 동의서 서식
타당화·검증 근거	외부 법적 검토 버전(「(법적 검토 요청한 버전) 강의콘텐츠 저작권 및 활용 동의서」)을 거쳐 개정. 2026.2.28. 실무진 회의에서 저작권·초상권·윤리 리스크 관리기준으로 확정
활용 방법 및 배포 계획	콘텐츠 업로드 전 개발 교원으로부터 동의서를 징구하는 절차로 운영. 콘텐츠 사용기간(기본 3년) 경과 시 갱신 여부를 재확인
한계 및 보완 필요사항	개정 이력에 따라 여러 버전이 존재하므로, 참여대학이 항상 최신 확정본을 사용할 수 있도록 배포본 관리 체계를 유지한다. 외부 저작물(그림·폰트 등) 사용 여부에 대한 사전 확인 절차는 2차년도에 품질심사 단계의 점검 항목으로 편입할 예정이다.

항 목	내 용
산출물명	K-MedU 콘텐츠 품질관리 평가표 및 심사 프로세스
개발 절차	2026.1.15. 워크숍에서 5단계 품질관리 모델 제시 → 2026.2.28. 실무진 회의에서 업로드→검수→오픈(학점인정) 절차 확정 → 2026.7.21.~7.27. 심사 프로세스 재정의(심사위원 개별 평가 + 심사위원장 종합의견 방식)
타당화·검증 근거	대학 자체 검수 → KAMC 품질심사의 2단계 환류 체계로 설계. 심사위원 풀을 대학당 3명씩 약 120명 규모로 구성하여 심사자 편중을 방지
활용 방법 및 배포 계획	콘텐츠 업로드 시 예비심사-본심사-개설심의 순으로 적용. 심사 결과는 개발 교원에게 환류하여 보완 후 재제출
한계 및 보완 필요사항	2026.7월 프로세스를 재정의한 직후이므로 대규모 심사 운영을 통한 심사 기준의 일관성 검증이 필요하다. 심사위원 사전 교육 (캘리브레이션) 체계는 2차년도에 도입할 예정이며, 2026.9월 비대면 심사위원 교육을 그 출발점으로 시행한다.

항 목	내 용
산출물명	대학관리자·중앙관리자 운영 매뉴얼
개발 목적·활용 대상	K-MedU 플랫폼의 대학별 운영 실무를 표준화하기 위한 매뉴얼. 각 대학 대학관리자와 KAMC 중앙관리자가 활용 대상
개발 절차	플랫폼 구축 완료(2026.4.30.) → 2026.6.9. LMS 설명회 운영 → 설명회 피드백 반영 → 2026.7.16. 초안, 2026.7.25. 수정본을 거쳐 2026.7.27. 최신본 확정
주요 구성·목차	대학관리자용: 부서·과정 확인, 권한 관리, 기수 추가, 수강 대상 학생 등록, 콘텐츠 업로드 및 품질심사 신청 절차. 중앙관리자 용: 대학 계정 발급·관리, 과정 개설 승인, 품질심사 진행 관리
타당화·검증 근거	2026.6.9. LMS 설명회에서 참여대학 실무자 대상 시연 및 질의 수렴. 「대학관리자 관리문서」로 대학별 설정 진행 현황(부서·과정·권한 설정, 계정 발급, 협약서 체결)을 상시 점검
활용 방법 및 배포 계획	참여대학 실무자에게 배포하며, 신규 참여대학 온보딩 시 기본 자료로 사용. 플랫폼 기능 개선 시 개정판을 배포하는 방식으로 운영
한계 및 보완 필요사항	2026.9월 시범학기는 대학 담당자가 수강 대상 학생을 수동 등록하는 방식으로 운영되어, 정식 수강신청 방식 전환 시 매뉴얼 전면 개정이 필요

4. 시범운영 결과

구 분	내 용
시범운영 대학·대상	부산대학교(주 운영)·고신대학교 「임상윤리」 교과목 — 학생 143명 및 부산대 교수·조교 약 7명(상세는 V.3 참조)
운영 기간·규모	2026.4.27.~4.30. 4일간 운영(영상강의 11편·토론자료 업로드), 설문 2026.4.27.~5.8.
운영 방식	온라인 사전학습 후 오프라인 사례토의로 연계하는 플립러닝(flipped learning) 방식
정량 결과	학습효과·플랫폼 사용성 설문을 익명으로 실시(응답 58명, 12문항 5점 척도). 주요 결과는 다음과 같다. 사전학습이 오프라인 참여에 도움이 되었다 4.76 / 사례 토론이 윤리적 쟁점 이해에 도움이 되었다 4.72 / 본 수업 방식에 만족한다 4.72· 교수자 진행이 효과적이었다 4.71 / 영상이 윤리 개념 이해에 도움이 되었다 4.69 / 적극적 참여를 유도하였다 4.69 / 윤리 문제 분석 능력이 향상되었다 4.69· 타 대학이 개발한 콘텐츠를 활용하는 공유대학 방식이 유용하다 4.69 / 다양한 관점을 고려하게 되었다 4.64 / 영상은 이해하기 쉬웠다 4.62· 다른 과목에도 적용되면 좋겠다 4.60 / 임상에서 윤리 문제를 다룰 자신감이 향상되었다 4.59(전 문항 4.59 이상으로, 공유 교육과정 방식 자체에 대한 유용성 평가도 4.69로 높게 나타남)
정성 결과	주관식 응답에서 확인된 장점은 ① 개별 대학이 단독으로 제공하기 어려운 전문 분야 교육 경험 제공 ② 특정 대학에 부족한 전문 교수진을 대학 간 협력으로 보완한다는 점이었다. 반면 한계로는 ① 비실시간 온라인 강의의 특성상 실시간 질의응답·교수자 상호작용에 제약이 있고 ② 제한된 오프라인 시간으로 전원에게 충분한 실습·토론 기회를 보장하기 어렵다는 점이 지적되었다. 운영 과정에서는 교수자가 직접 자료를 업로드하며 시스템을 실사용 검증하였고, 계정 생성·조교 권한 부여·학습자 관리 기능을 점검하여 발생 문제를 실시간으로 수집·개선하였다.
본 과제 산출물에 반영한 사항	콘텐츠 업로드 UI, 조교 권한 기능, 콘텐츠 품질관리 체크리스트에 파일럿 결과 반영

5. 학술적 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
1	System-Level Design Principles and Institutional Implementation Conditions for a National Shared Medical Curriculum in South Korea (K-MedU): An Exploratory Sequential Mixed-Methods Study	원저논문(미출간 원고)	투고 예정	투고 예정

6. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
대외 시연	KAMC 정기총회 공유대학 플랫폼 기능 시연	전국 의과대학 학장단 등 KAMC 정기총회 참석자	2026.2.26.
설명회	LMS 설명회 및 시스템 설명회(공유대학 플랫폼 사용법 안내)	참여대학 실무담당자	2026.6.9.(LMS), 2026.7.9.(시스템)
교육자료 배포	K-MedU 강의개발 FAQ v2(전체 42문항, 이 중 20문항은 1차 배포 후 운영 중 제기된 질문을 반영한 신규 문항)	참여대학 교원 전체	2026.5.12. 개정판 배포

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
KAMC 주관개발 콘텐츠(코어플러스)	주관교수(저작자)와 KAMC가 공동 소유	K-MedU 플랫폼 내(Closed/Open 구분, 상업적 이용 금지)	KAMC 사무국
K-MedU 학습플랫폼(시스템)	KAMC	참여대학 교원·학생(권한별 접근)	KAMC(위탁 개발사 유비온)

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
1	플랫폼 개발	Y (개발 완료)	달성 — 구축 완료(2026.4.30.), 2026.6.9. LMS 설명회 및 시범운영 개시, 2026.9.1. 정식 오픈	100%	「[의과대학 교육혁신 지원사업] 공유대학 학습 플랫폼 구축 완료보고서」(㈜유비온, 계약 2025.12.9.~완료 2026.4.30.)
2	공유 교육과정 개발 수	50개	625건 (참여대학 575차시 + KAMC 자체 개발 50시수)	1,250%	「대학관리자 관리문서_20260804.xlsx」 대학콘텐츠 시트 — 22개교·73개 모듈·575차시 / 「K-MedU 공유 콘텐츠 제작 완료보고서」(㈜에듀콤, 2026.3.25.~7.31., 강의영상 50시수·교안 50개·국영문 자막 각 50개 납품)
3	공유 교육과정 활용 학생 수	200명	143명 (부산대 62명, 고신대 81명)	71.5%	user_register 등록명단(부산대·고신대), 2026.4.2.~4.23. 회의록
기타	참여대학 수 / 학점교류 업무협약 체결 대학 수	(사업계획서 미설정)	참여 26개교 / 학점교류 업무협약 체결 22개교	— (추가 달성 실적)	「대학관리자 관리문서_20260804.xlsx」 대학관리자 시트 '협약서 여부' 항목
※ 지표 2번 실적의 집계 기준일과 변동 가능성은 Ⅲ.2 주석 참조.					

2. 목표 미달·초과 항목 분석

지표	구분(미달/초과)	원인 분석	보완 계획
공유 교육과정 개발 수	초과 (달성률 1,250%)	목표치 50개가 KAMC 자체 개발분만을 전제로 산정되어 참여대학의 자체 개발분이 반영되지 않았다. 실제로는 26개 참여대학이 자교 특성화 분야를 공유 콘텐츠로 개발하는 흐름이 형성되어 575차시가 추가로 확보되었다.	2차년도에는 개발 수의 추가 확대보다 이미 개발된 콘텐츠의 품질 심사와 실제 개설·활용에 집중한다(X표장 참조). 아직 실적이 취합되지 않은 대학의 개발 현황을 확인하여 집계를 완결한다.
공유 교육과정 활용 학생 수	미달 (달성률 71.5%)	플랫폼 정식 오픈이 2026.9.1.로 예정되어 1차년도 중에는 「임상윤리」 시범운영(2개교 143명) 외의 정규 수강이 발생하지 않았다.	2026.9월 정규 학기 개강과 함께 수강 등록 현황을 집계한다. 2차년도 성과지표에도 활용 학생 수 200명을 유지하여 개강 직후 목표를 충족하도록 한다.
플랫폼 개발 / 참여대학·협약 체결	해당 없음 (목표 달성)	목표치를 충족하여 미달·초과 항목에 해당하지 않는다.	—

3. 자체 평가

구 분	내 용
잘된 점(강점)	첫째, 1차년도 핵심 목표였던 학습플랫폼 구축과 콘텐츠 개발을 모두 기한 내 완료하여 성과지표 1.2번을 달성하였다(수치와 증빙은 Ⅷ.1 참조).둘째, 콘텐츠 개발-심사-운영의 표준 체계를 문서로 확정하였다. 표준 운영 서식 6종과 3단계 심의 구조·5개 영역 평가 체크리스트를 갖추으로써, 개별 대학의 개발 역량 차이와 무관하게 공유 콘텐츠의 최소 품질을 담보하는 장치를 마련하였다.셋째, 22개교의 학점교류 업무협약을 확보하여 대학 간 협약에 근거한 학점 인정 구조를 실제로 가동할 수 있게 되었다.넷째, 구축한 체계를 「임상윤리」 공동 교육과정 시범운영을 통해 실제 수업 환경에서 검증하였고, 수강생 설문에서 전 문항 평균 4.59~4.76의 높은 만족도를 확인하였다.다섯째, 참여 대학의 자체 콘텐츠 개발이 실질적으로 착수되어(22개교 575차시) 사업 종료 후에도 콘텐츠가 지속 공급될 기반이 마련되었다.
부족한 점(한계)	첫째, 성과지표 3번(공유과정 활용 학생 수)은 1차년도 내 최종 집계가 불가능하였다. 플랫폼 안정화를 위한 테스트 기간을 거쳐 2026년 9월 정식 오픈 이후 본격적인 운영이 시작되므로, 시범운영 참여자 외의 활용 실적은 사업기간 종료 이후에야 확인된다.둘째, 콘텐츠 심사·탑재 체계의 운영 준비가 일정에 쫓겼다. 9월 학기 운영을 위해 심사 시스템 개발을 8월 중 완료해야 했고, 심사위원 풀 구성과 비대면 교육이 2026년 9월로 미뤄졌다. 심사위원 간 평가 편차를 줄이기 위한 사전 교육 체계는 아직 정비 중이다.셋째, 학점교류 업무협약 체결이 참여 의향을 밝힌 대학 전체로 확대되지는 못하였다. 미제출 대학의 주된 사유는 타 대학 콘텐츠의 학점 인정을 위한 학칙 개정 부담과 대학 본부의 승인 절차였다(상세는 X장 참조). 표준 협약 양식과 사전 설명자료로 승인 절차를 지원하였으나 대학 간 체결 시점의 편차는 완전히 해소되지 못하였다.넷째, 온·오프라인 연계 수업 설계에 대한 지원이 부족하였다. 1차년도의 지원은 온라인 콘텐츠의 제작 기준과 품질관리에 집중되었고, 콘텐츠를 어떤 오프라인 활동과 어떻게 연계할 것인지에 대한 수업 설계 지원은 상대적으로 미흡하였다. 온라인 학습과 대면 수업이 유기적으로 연결되지 않으면 공유 콘텐츠가 단순 시청 자료에 머무를 수 있으므로, 블렌디드 수업 설계 가이드와 대학별 운영 사례의 공유가 보완되어야 한다.다섯째, 참여에 대한 보상 체계가 마련되지 않았다. 콘텐츠 개발과 운영에는 참여 대학과 교수의 상당한 시간과 비용이 투입되나 이를 교원 업적으로 인정하거나 운영 인력에 보상하는 기준은 각 대학과 사업 차원 모두에서 정비되지 않은 상태이다. 유인이 확보되지 않으면 콘텐츠의 지속 공급과 품질 유지가 어렵다(X I 장 참조).
예상하지 못한 성과	첫째, 참여 대학의 자발적 콘텐츠 개발 규모가 당초 목표를 크게 상회하였다. 특히 각 대학이 자교 특성화 분야(항공우주의학, 청각장애 환자 의사소통, 지역 특화 환경응급의학 등)를 공유 자산으로 내놓는 흐름이 나타난 것은 사업 설계 단계에서 예상하지 못한 성과이다.둘째, 현장의 실무 질의가 예상보다 구체적이고 방대하여 이를 반영한 FAQ가 독자적 산출물로 발전하였다. 「K-MedU 강의개발 FAQ」는 1차 배포 후 실제 운영 과정에서 제기된 질문을 반영해 개정판(v2, 42개 항목 중 20개가 신규 문항)으로 확대되었다.셋째, 플랫폼 시연이 확산의 계기로 작용하였다. KAMC 정기총회 시연과 성과공유세미나를 통해 미참여 대학의 문의와 참여 의향 표명이 이어졌다.
종합 의견	본 과제는 1차년도 핵심 목표인 학습플랫폼 구축과 강의 콘텐츠 개발을 모두 기한 내 달성하였다. 아울러 콘텐츠 개발기준·품질관리 체계·학점교류 협약이라는 세 축의 운영 기반을 문서로 확정하고 이를 시범운영을 통해 실제 수업 환경에서 검증하였다는 점에서 계획 대비 충실한 성과를 거두었다고 판단한다. 다만 본 과제의 최종적 성패는 구축된 플랫폼에 콘텐츠가 지속적으로 공급되고 학생이 이를 학점으로 이수하는 단계에서 결정되므로, 2차년도에는 협약 체결 대학의 확대, 심사·탑재 체계의 안정적 가동, 활용 학생 수의 실질적 확보가 우선 과제가 된다.

07 성과 확산 및 활용 방안

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
미참여 의과대학(전국 40개교 중 미참여교)	대학관리자 대상 설명회 및 공문 발송	2026.9월~	참여대학 확대를 통한 콘텐츠 다양성 및 활용도 제고
참여대학 학생 전체	LMS를 통한 수강신청 안내, 교수자 소통채널 개설	2026.9월 학기~	학생 접근성 확대 및 활용 학생 수 증대(KPI 목표 반영)
KAMC 회원 의과대학 전체	성과공유세미나, KAMC 정기총회 시연	지속(연 1~2회)	사업 인지도 제고 및 신규 참여 유인
콘텐츠 품질 심사위원 풀	참여대학당 3명씩 추천, Zoom 비대면 교육	2026.9.1.~	콘텐츠 품질관리 체계의 지속가능한 운영기반 확보

2. 대학별 적용 사례

대학명	적용 내용	적용 시기	성과·시사점
가천대학교	통합감염학 1강좌(의료인문학·생화학·임상감염학·특수상황감염 4개 모듈, 15개 강의) 개발	2026.6.~8월	3차에 걸친 내부 검수 후 K-MedU 예비심사 제출 완료, 학점교류 업무협약 체결
가톨릭대학교	특화 교과목 5과목(의료와 인공지능·데이터의학·합성의학·나노의학·로봇의학) 총 35강 개발	2026년 개발 중	의사과학자 양성 및 디지털 전환 기반 의학교육 강화 콘텐츠를 K-MedU와 공유 예정
건국대학교	3과목(대학생물학·유기화학·의공학) 90시수, 24개 모듈 개발	2026년	의예과 기초교육의 질 관리 기반 확보, 의학·과학·공학 융합교육 기반 마련
건양대학교	공유용 콘텐츠 108개(35개 모듈) 개발 — 선도개발 15개(6모듈)·디지털전환 22개(8모듈)·집중개발 71개(21모듈)	2026년	플립러닝 기반 온·오프 연계형 콘텐츠 제공을 위한 설계 워크숍 실시, 초광역 협업 콘텐츠 다수 개발
경희대학교	의료AI 등 4개 강의 동영상 K-MedU 플랫폼 탑재	2026년 하반기	KAMC 표준 템플릿 기반 졸업포트폴리오·문항뱅크 등 타 과제와 병행 추진
계명대학교	자체 개발 공유교육과정 「진로탐색」 15시수	2026년	교내·외 의과대학 교수 및 각 분야 전문가 30인 내외 참여 — 다기관 강사 참여형 개발 모델
단국대학교	2건 개발 — 외상학(START) 16차시, 의료와 리더십1 15차시 (5개 모듈)	2026년	콘텐츠 기획→수업설계·강의계획서→촬영·제작→편집·자막검수→검수 및 KAMC 제출→공유대학 탑재의 표준 제작 단계 정립
대구가톨릭대학교	공유 교육과정(CARITAS-NET) 41강, 총 1,025분, 4개 모듈 개발	2026.7월 플랫폼 탑재 목표	목표 8개 모듈 대비 7개 개발 완료. 본교 강점 반영(특수생리·사회윤리·청각장애 환자 의사소통·특수환자 의사소통)
성균관대학교	성균관의대형 온라인 공유 교육과정 콘텐츠 48건 확보	2026년	목표 30건 대비 160% 달성, 인문사회·기초·임상의학 전 영역 콘텐츠 포트폴리오 구성

대학명	적용 내용	적용 시기	성과·시사점
순천향대학교	공유교과 16시수 동영상(의사와 사회, 데이터사이언스 교육 등) 교육계획 수립·제작	2026년	학교·의대 간 공유교과 학점 이수 인정에 관한 규정 논의 진행 중
아주대학교	K-MedU 공유강의 9개 모듈, 36시수 개발	2026년	전국 의과대학이 공동 활용 가능한 자원 구축
연세대학교	「사구체질환」 주제 3개 모듈 15강 개발(책임: 김혜원 교수)	2026년	K-MedU 공유대학 학점교류 업무협약 체결, 온라인 스튜디오 구축 및 촬영 장비 도입, 성과공유세미나 3회 참여
연세대학교 원주	디지털 역량 4개 모듈(의료정보보호와 전문직 윤리·의료 AI 기본·임상 디지털 리터러시와 상호운용성·생물정보학) 15차시 제공	2026년	모듈별 학습성과와 관련 학습역량을 연계한 구조로 설계
영남대학교	미래의학 8차시·의료인문 8차시 등 16차시 개발	2026.4.~7월	사업계약→내용전문가 워크숍→프로토 원고 수급→교안 개발→본 강의 촬영→중간보고회→전 과목 개발의 일정 관리 모델 적용
인하대학교	특성화 분야 2강좌 30차시 개발 — 「하늘을 넘어, 우주로 가는 의사들」 15차시, 「코딩 가운을 입은 의사」 15차시	2026년	대학 특성화 분야(항공우주의학·헬스케어데이터)를 공유 콘텐츠로 자산화
제주대학교	「스토리텔링으로 배우는 환경응급 및 야생의학」 5개 모듈 15차시 개발	2026년	1학점(15시수) 공유 교육과정으로 개발, 지역 특화 교육 자원의 전국 공유 모델 제시
차의과학대학교	피부과학 약 15시수, 근골격계학 약 15시수 개발	2026년	최종 영상 검수 후 전국 의과대학 대상 개방 예정
충북대학교	기초·임상의학 3개 과목 15시수 개발(의학용어의 기원 5차시, 백신학 8차시, 내 몸 속의 호르몬 이야기 2차시)	2026년	해부학·미생물학(면역학)·내과학(내분비) 교실 간 협업으로 기초-임상 연계 콘텐츠 구성
한양대학교	KAMC 공유 동영상 콘텐츠 15강·10개 모듈 개발·공유	2026년	6대 세부사업 중 공유대학(K-MedU) 영역의 핵심 산출물로 관리

대학명	적용 내용	적용 시기	성과·시사점
강원대학교	「강원도의 질병, 의료, 사회」 1강좌 15차시 — 3개 모듈(근대 의료의 이식과 식민지적 재편 / 전쟁·산업화와 의료 격차의 구조 / 지역 정주와 의사의 사회적 책무)	2026년	지역 의사·의료인문학을 공유 콘텐츠로 자산화
경상국립대학교	「의료커뮤니케이션」 5개 모듈 14차시 개발(의사소통의 이해 / 나와 타인의 이해 / 관계의 이해 / 의료커뮤니케이션의 이해 / 상황별 의료커뮤니케이션)	2026년	의사소통 역량 교육을 단계형 모듈로 구성
동아대학교	「임상윤리」 15시수 개발 — 동영상 11시수(5개 모듈) + 오프라인 토론·평가 4시수	2026년	온라인 사전학습-오프라인 사례토의 연계형 콘텐츠. 부산대·고신대 시범운영에 실제 활용된 첫 공유 교육과정
부산대학교	「기생충학총론」 등 103시수 개발	2026년	참여대학 중 개발 규모 최대. 「임상윤리」 공유 교육과정 시범운영(62명) 주관교로 참여
원광대학교	2강좌 38시수 개발 — 「영양과건강」 30시수, 「잠수생리학」 8시수	2026년	대학 특성화 분야(잠수의학)를 전국 공유 자산으로 제공
※ 집계 기준	본 표는 2026. 8. 7. 현재 집계 기준이다(변동 가능성은 Ⅲ.2 주석 참조).	—	—

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

K-MedU 플랫폼은 현재 자체 퀴즈(CBT 형태 문항 등록·채점) 기능을 구현하여 운영 중이나, KAMC 총괄사업 내 문항뱅크·포트폴리오 평가 플랫폼 등 타 개별과제의 인프라와의 기술적 연계는 아직 협의 단계로, 1차년도 중 실제 시스템 연동 실적은 없다. 2차년도에는 KAMC 총괄 차원에서 문항뱅크·포트폴리오 평가 플랫폼 담당 과제와 연계 방안을 협의하여, 공유 교육과정 이수 결과가 타 인프라(문항은행 기반 평가, 학생 포트폴리오 등)에도 반영될 수 있도록 검토할 계획이다.

4. 지속 가능성 확보 방안

운영 주체 및 관리 체계 (KAMC / 권역 / 대학)

K-MedU 공유대학의 운영은 KAMC를 중앙 운영 주체로 하고 참여 대학이 자교 운영을 담당하는 이원 체계로 한다. KAMC 사무국은 중앙관리자로서 플랫폼 전반의 운영·유지보수, 회원 및 권한 관리, 콘텐츠 심사 접수와 개설 심의, 통계 관리를 담당한다. 각 참여 대학은 대학관리자를 지정하여 자교 학생의 수강 관리, 자교 개설 콘텐츠의 등록과 1차 자체 검수, 성적 부여와 학점 인정을 담당한다. 이 이원 구조는 「대학관리자·운영자 매뉴얼」과 「중앙관리자 매뉴얼」로 문서화되어 있다.

콘텐츠의 품질은 품질관리위원회가 관장한다. 위원회는 접수-예비심사-본심사-개설심의의 3단계 심의를 운영하며, 심사위원은 참여대학당 3명씩 추천받아 풀(pool)을 구성한다. 성적 부여와 학점 인정 권한은 담당교수-책임교수 이원 구조에 따라 학생 소속 대학에 남는다(Ⅱ.5 참조).

갱신·고도화 주기 및 방법

콘텐츠 갱신은 내용의 최신성을 기준으로 수시 개정 방식으로 관리한다. 의학 지식과 진료지침은 개정 시점이 일정하지 않으므로 갱신 주기를 일률적으로 정하지 않고, 담당교수 또는 참여 대학의 요청이 있거나 품질관리위원회의 검토에서 개정 필요가 확인되는 경우 수시로 콘텐츠를 수정·교체한다. 저작물 이용 안내 및 활용 동의서에 정한 사용기간이 만료되는 콘텐츠는 저작권자의 재동의 절차를 거쳐 계속 활용 여부를 결정한다.

품질 측면에서는 개설 후에도 수강생 설문과 이수 통계를 추적하여 품질관리위원회가 정기적으로 검토하고, 기준에 미달하는 콘텐츠는 보완 요구 또는 개설 중단 절차를 적용한다.

플랫폼 고도화는 2차년도 이후 단계적으로 추진한다. 우선순위는 ① 평가 신뢰성 확보를 위한 부정행위 방지 기능, ② 모바일 환경 완전 호환, ③ 사전·사후 학습 성과 설문의 자동 연계, ④ 블록식 통합수업 등 대학별 학사 운영 방식을 유연하게 수용하는 기능, ⑤ 사업 내 타 인프라와의 연계(VIII.3 참조)이다.

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

구분	쟁점·애로사항	원인	대응 및 개선 제언
제도	대학별 원격교육 이수 규정이 달라 공유 콘텐츠를 일괄 적용하기 어렵고, 학점교류 업무협약(MOU) 체결에 대학 본부 승인이 필요해 행정 부담이 크다.	대학별 학칙상 온라인 강의 인정 범위가 상이하며(2025.7.26. 킥오프 회의), 재정 지원이 수반되는 MOU는 본부 승인 절차가 까다롭다(2026.2.26. 회의).	대학별 예외조항·가이드라인 마련과 온라인 활용 허용 비율 확대(최대 50%) 검토, 표준 MOU 양식 및 사전 설명자료 제공으로 승인 소요기간 단축. 1차년도 중 22개교와 협약을 체결하였다.
현장 운영	40개 의과대학의 학사일정(개강·종강·시험기간)이 상이하여 실시간 연동강의와 공동평가 운영이 곤란하다.	대학별 학사력 불일치(2026.2.26. KAMC 정기총회 시연 회의).	실시간 연동 대신 온디맨드(비실시간) 콘텐츠 중심으로 운영하고, 최종 성적 부여와 학점 인정 권한은 학생 소속 대학이 보유하는 유연한 구조를 채택하였다.
인력·보상	초기 강의개발 계획서 양식이 복잡하고 개발자·운영자 역할 구분이 불명확하였으며, 콘텐츠 심사위원 풀과 교육 체계가 미비하다.	최초 양식이 다수 항목을 포괄하도록 설계되었고(2025.11.27. 제5차 연구회의), 9월 학기 운영에 맞춘 심사 시스템 개발 일정이 촉박하다(2026.7.21.·7.27. 회의).	양식 구조를 단순화하고 역할별 작성 가이드를 별도 배포하였다(강의개발 FAQ v2). 참여대학당 3명씩 약 120명 규모의 심사위원 풀을 구성하고 비대면 교육(2026.9.1. 예정)을 시행한다.

2차년도·후속 방향

2026학년도 2학기 정규 운영과 콘텐츠 품질심사를 정착시키고 신규 강의 개발·활용 워크숍을 추진합니다.